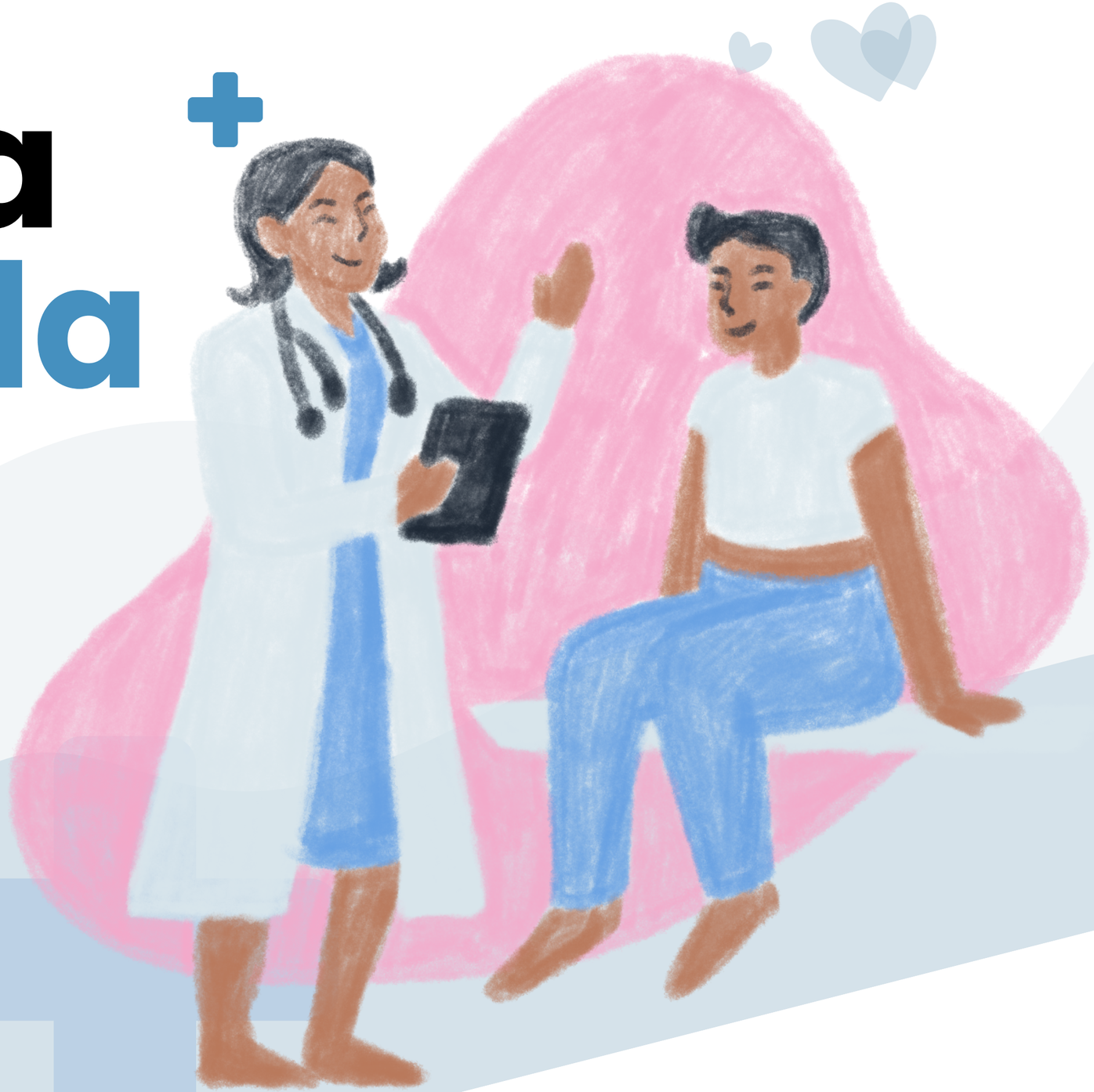
Misoginia na área da saúde



Componentes do grupo:

- João Henrique Vogado Lima;
- Juliana Mel Soares Mutran;
- Kawany Beatriz Araújo Sousa;
- Luís Guilherme Lebedeff Rocha Mota;
- Mariana Cardoso Lima;
- Ryan Gabriel Araújo Almeida.



Medicina, educação e misoginia

Aproximadamente nove Institutos de ensino de medicina japoneses manipularam admissões, em parte para barrar a entrada de estudantes do sexo feminino, concluiu uma investigação governamental.

“Muitas estudantes do sexo feminino que se formam acabam deixando a prática médica real para dar à luz e criar os filhos”, disse a fonte ao jornal.



Desvendemos:

“A father and son are in a car accident. The father dies, and the son is rushed to the hospital. When the surgeon sees the boy, they say, "I cannot operate on him; he is my son.”

R: The surgeon is the boy's mother.



“Pai e filho sofrem um acidente de carro. O pai morre e o filho é levado às pressas para o hospital. Quando a cirurgiã vê o menino, ela diz: "Não posso operá-lo; ele é meu filho.”
R: A cirurgiã é a mãe do menino.

Esta charada foi criada para destacar o preconceito de gênero inconsciente. Muitas pessoas têm dificuldade para resolver o problema porque inconscientemente presumem que um cirurgião (uma profissão médica de alto status) deve ser homem. O enigma força o solucionador a confrontar o estereótipo de que os médicos são homens, levando-os a ignorar a possibilidade óbvia de que o outro progenitor seja uma mulher. Pesquisas indicam que uma parcela significativa de adultos, incluindo feministas auto-proclamados, inicialmente não consegue identificar o cirurgião como mulher, revelando esquemas de gênero profundamente arraigados em relação aos papéis profissionais.

Dados de atuação feminina na carreira médica

Sexo do cirurgião e resultados pós-operatórios de longo prazo entre pacientes submetidos a cirurgias comuns

Entre 1 165 711 pacientes incluídos, 151 054 foram tratados por uma cirurgiã e 1 014 657 por um cirurgião. No geral, 14,3% dos pacientes apresentaram 1 ou mais resultados pós-operatórios adversos em 90 dias e 25,0% apresentaram 1 ou mais resultados pós-operatórios adversos 1 ano após a cirurgia. Entre estes, 2,0% dos pacientes morreram em 90 dias e 4,3% morreram em 1 ano. As taxas ajustadas multivariáveis do ponto final composto foram maiores entre pacientes tratados por cirurgiões do sexo masculino do que do sexo feminino em 90 dias. Padrões semelhantes foram observados para mortalidade em 90 dias.

Após considerar as características do paciente, do procedimento, do cirurgião, do anestesiologista e do hospital, os resultados deste estudo de coorte sugerem que pacientes tratados por cirurgiãs apresentam menores taxas de resultados adversos pós-operatórios, incluindo morte em 90 dias e 1 ano após a cirurgia, em comparação com aqueles tratados por cirurgiões homens. Essas descobertas reforçam ainda mais as diferenças nos resultados dos pacientes com base no sexo do médico, o que justifica um estudo mais aprofundado sobre as causas subjacentes e possíveis soluções.

Se os resultados clínicos não sustentam a ideia de superioridade profissional masculina, por que a competência das mulheres na medicina ainda pode ser questionada ou reconhecida de maneira desigual?



Misoginia na medicina e o atendimento ao público

O exemplo da endometriose:

Pesquisas recentes descobriram que vários fatores podem atrasar o diagnóstico da endometriose em até 11 anos devido a barreiras pessoais e sociais e às ações e formação dos profissionais de saúde.

- “Estima-se que [uma] em cada 10 mulheres tenha endometriose, mas às vezes é difícil fazer o diagnóstico porque atualmente não existem modalidades de diagnóstico não invasivas, como ultrassonografia ou exames de sangue, que diagnostiquem a endometriose de forma confiável.”
  — Dra. Ann Peters

- No nível individual, descobriu-se que as mulheres tinham dificuldade em entender a dor menstrual típica. Por exemplo, havia uma suposição comum entre os participantes de que a dor era típica e que eles simplesmente tinham que lidar com ela. Essas ideias e o uso de medidas de autocuidado para controlar os sintomas provavelmente influenciaram o momento do diagnóstico da endometriose.
- No nível interpessoal, os pesquisadores descobriram que o estigma em torno da discussão de problemas menstruais e da visão da sociedade sobre a dor menstrual como normal pode ter contribuído ainda mais para o atraso no diagnóstico.
- Por fim, fatores de saúde e endometriose influenciaram o momento do diagnóstico. Por exemplo, os participantes relataram que os médicos generalistas ignoravam preocupações ou pareciam não ter conhecimento sobre endometriose. Da mesma forma, os profissionais de saúde participantes também expressaram treinamento inadequado em relação à endometriose, e muitos notaram que também não tinham diretrizes clínicas claras para o diagnóstico.



Estudo de caso rápido:



Uma causa improvável para o colapso pulmonar

Um caso ocorrido a uma paciente de nome Zara Altbach, onde seu pulmão entrou em colapso 3 vezes, algo raro de se acontecer:
“Toda vez que eu ia ao pronto-socorro ou ao pronto-socorro para fazer um raio-X, era na época em que eu estava ovulando ou menstruada.” Ela compartilhou isso com o Dr. Patton, que então ofereceu pneumotórax catamenial como explicação. Uma condição rara e episódica na qual o pneumotórax ocorre dentro de 72 horas após a menstruação, o pneumotórax catamenial é normalmente encontrado no lado direito do corpo em pacientes com endometriose.

No mundo, uma em cada 10 mulheres tem endometriose, uma doença na qual o crescimento anormal de tecido fora do útero causa a formação de lesões, que frequentemente se espalham para diferentes órgãos. Os sintomas incluem menstruações dolorosas, evacuações dolorosas e muito mais.

Não há cura conhecida.

Estudo de caso rápido:

Um caso semelhante mais recente (Setembro de 2026):

Quando Chakia Bradford, 32 anos, percebeu pela primeira vez que estava com falta de ar em abril do ano passado, ela presumiu que eram alergias graves.

Ela foi ao seu médico habitual, que tirou raios-X. Bradford só recebeu os resultados no dia seguinte, mas foi instruída a ir ao hospital imediatamente. No hospital, os médicos confirmaram que ela tinha líquido no espaço ao redor dos pulmões, o que dificultava sua respiração. Eles acabaram removendo cerca de 2 litros de líquido sangrento dos pulmões de Bradford, diz ela, o que a fez sentir como se estivesse se afogando.

Bradford acabou ficando no hospital por pouco mais de uma semana enquanto sua equipe médica investigava. Finalmente, um médico entrou e começou a perguntar a Bradford sobre sua menstruação, que tinha sido terrivelmente dolorosa nos últimos oito anos ou mais.

Eles perceberam que o fluido pulmonar de Bradford poderia estar relacionado à menstruação. Mas como ela não havia sido diagnosticada com uma doença como a endometriose, que causa uma série de sintomas dolorosos ao longo do ciclo menstrual, os médicos não tinham certeza.

De sua cama de hospital, Bradford marcou uma consulta com seu obstetra e ginecologista. Bradford esperava falar sobre a possibilidade de ter endometriose, mas “ela meio que me ignorou”, lembra Bradford, “como se os outros médicos ou eu não soubéssemos do que eu estava falando”

Então Bradford foi para casa e tentou voltar à sua vida normal. Mas cerca de um mês depois, “tive outro colapso pulmonar e falta de ar”, ela diz. “Então isso acontece toda vez que meu ciclo chega.”

Desta vez, Bradford foi direto ao hospital e, após mais exames, descobriu que muito provavelmente tinha endometriose.



Momento para pensar:

Retraído: Atratividade de mulheres com endometriose retovaginal: um estudo de caso-controle

Objetivo: Investigar se havia diferenças na atratividade física entre mulheres com endometriose retovaginal, mulheres com outras formas de endometriose e mulheres sem a doença.

Conclusões: Mulheres com endometriose reto-vaginal foram consideradas mais atraentes do que aquelas nos dois grupos de controle. Além disso, tinham silhueta mais magra, seios maiores e coitarca mais precoce.

O estudo apresentado foi postado em 2012, e retraído em 2020.

O motivo apresentado de acordo com os autores foi o seguinte:
“Conduzimos o estudo de boa fé e de acordo com a metodologia correta. Acreditamos que nossas descobertas foram parcialmente mal interpretadas, mas, ao mesmo tempo, percebemos que o artigo pode ter causado sofrimento a algumas pessoas. O respeito das mulheres é uma prioridade para nós e lamentamos profundamente o descontentamento originado pela publicação.”

Fica então a seguinte pergunta:

Porque há dinheiro investido em pesquisas desse tipo em alta escala, mas temos tão pouco investimento sobre pesquisas no tratamento e cura da endometriose, ou mesmo em menos efeitos colaterais para métodos contraceptivos para mulheres?

Você já passou por/testemunhou alguma experiência parecida com algo apresentado?



Esse não exatamente é um momento necessariamente de compartilhar, mas também de refletir.

Você não precisa compartilhar com os seus colegas, mas sinta-se livre para o fazer se interessado, ou somente refletir.



Referências:



Tokyo Medical University 'changed female exam scores':
https://www.bbc.com/news/world-asia-45108272

Tokyo Medical University apologises for changing female exam scores:
https://www.bbc.com/news/world-asia-45043818

Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries:
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2808894?guestAccessKey=2b9a1b6f-4876-4b26-9917-1a93679f37e0

Retracted: Attractiveness of women with rectovaginal endometriosis: a case-control study:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22985951/

An unlikely cause for collapsed lung:
https://www.northwell.edu/news/an-unlikely-cause-for-collapsed-lung

Time to Diagnose Endometriosis: Current Status, Challenges and Regional Characteristics—A Systematic Literature Review:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11625652/

(Ainda mais) Referências:

Woman's rare form of endometriosis made her lung collapse after doctor dismissed symptoms for years:
https://www.nbcchicago.com/news/health/texas-woman-endometriosis-stage-4-lung-collapse/3990737/

Why does receiving a diagnosis for endometriosis take so long?
https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-does-receiving-diagnosis-endometriosis-take-so-long#Barriers-to-an-endometriosis-diagnosis

